

Система органов дыхания

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

Симптом «барабанных палочек» определяется с помощью {

=осмотра

~пальпации

~перкуссии

~аускультации

~рентгенографии

}

Искривление позвоночника вперед называется {

~кифоз

=лордоз

~сколиоз

~кифосколиоз

~ни одно из вышеперечисленного

}

Выберите из перечисленных одну из нормальных форм грудной клетки: {

=астеническая

~рахитическая

~паралитическая

~ладьевидная

~воронкообразная

}

Выберите виды одышки при которых наблюдается дыхательная пауза (периодическое дыхание) {

~Генча

~Куссмауля

=Чейна-Стокса

~Курвуазье

~Штанге

}

Спирали Куршмана обнаруживаются у больных с заболеваниями легких при лабораторном исследовании {

~мочи

~желчи

~желудочного сока

=мокроты

~плеврального выпота

}

Выберите вид одышки при которых отсутствует дыхательная пауза {

~Биота

=Куссмауля

~Чейна-Стокса

~Грока

~Инспираторная

}

При рестриктивных нарушениях вентиляции наиболее часто уменьшается следующий показатель легочной вентиляции

~дыхательный объем

~остаточный объем дыхания

=жизненная емкость легких

~общая емкость легких

~показатель пробы Тифно

}

Искривление позвоночника назад с образованием горба называется

=кифоз

~лордоз

~сколиоз

~кифосколиоз

~ни одно из вышеперечисленного

}

У больных, длительно болеющих бронхиальной астмой при осмотре можно выявить следующую форму грудной клетки

~апатитическую

=бочкообразную

~воронкообразную
~рахитическую
~ладьевидную.
}

Какой из вариантов искривления позвоночника встречается чаще всего {
~кифоз
~лордоз
=сколиоз
~все встречаются одинаково часто
~кифосколиоз
}

Как называется глубокое шумное редкое дыхание
~дыхание Чейн-Стокса
~дыхание Биота
~стридорозное дыхание
=дыхание Куссмауля
~ни одно из вышеперечисленного
}

Голосовое дрожание определяется с помощью {
~расспроса
~осмотра
=пальпации
~перкуссии
~аускультации
}

Ослабление голосового дрожания характерно {
~для бронхоэктазов
=для экссудативного плеврита
~для абсцесса легкого в стадии полости
~для очаговой пневмонии
~для крупозной пневмонии
}

Для крупозной пневмонии в разгар болезни характерен перкуторный звук {
~притупленный тимпанит

~коробочный
~тимпанический
=тупой
~металлический
}

Перкуторный звук над гладкостенной полостью, больших размеров, имеющей свободное сообщение с бронхом, имеет следующий характер {
=тимпанический
~металлический
~звука треснувшего горшка
~коробочный
~легочной
}

Для определения размера очага поражения легкого наилучшим методом является {
~сравнительная перкуссия
~рентгенография
=компьютерная томография
~топографическая перкуссия
~аускультация
}

Суммарная подвижность нижней границы правого легкого по средней подмышечной линии составляет {
~2-3 см
~3-4 см
=6-8 см
~1-2 см
~определить невозможно
}

Нижняя граница левого легкого по среднеключичной линии находится на уровне {
=6 ребра
~7 ребра
~8 ребра
~9 ребра

~ни одно из вышеперечисленного
}

Пикфлоуметрия - наилучший и простой метод определения: {
~сердечной астмы
~жизненной емкости легких
=пиковой скорости выдоха
~пиковой скорости вдоха
~ни одно из вышеперечисленного
}

Нижняя граница правого легкого по лопаточной линии находится на уровне
{
~6 ребра
~7 ребра
~8 ребра
~9 ребра
=10 ребра
}

Каким может быть перкуторный звук при приступе бронхиальной астмы {
~металлическим
~притупленным
=коробочным
~амфорическим
~притупленно тимпаническим
}

Топографическую перкуссию грудной клетки начинают со следующей области {
~боковой поверхности грудной клетки от подмышечной впадины книзу
~боковой поверхности от селезеночной или печеночной тупости кверху
=передней поверхности со второго и третьего межреберья
~задней поверхности от углов лопаток книзу
~задней поверхности от надключичных областей
}

Чем отличается коробочный перкуторный звук от ясного легочного {
~коробочный звук более высокий и продолжительный

~коробочный звук более громкий и высокий
~коробочный звук более низкий и продолжительный
=коробочный звук отличается более громким звучанием
~он более низкий, быстро затухающий
}

Сравнительная перкуссия начинается с перкуссии {
~надлопаточных областей
~межлопаточного пространства
=верхушек легких спереди
~ключиц
~подлопаточных областей
}

Усиление голосового дрожания типично {
~для гидроторакса
~для абсцесса легкого в стадии полости
=для крупозного воспаления
~для эмфиземы легких
~для бронхиальной астмы
}

К побочным дыхательным шумам не относится {
~шум трения плевры
~крепитация
=амфорическое дыхание
~влажные хрипы
~сухие хрипы
}

При эмфиземе легких дыхание {
~везикулярное
=везикулярное ослабленное
~везикулярное усиленное
~бронхиальное
~саккадированное
}

Стенотическое дыхание относится к {

=усиленному бронхиальному дыханию
~усиленному амфорическому дыханию
~ослабленному амфорическому дыханию
~усиленному металлическому дыханию
~ослабленному металлическому дыханию
}

Звонкие влажные хрипы характерны {
~для эмфиземы легких
~для абсцесса легких
~для крупозной пневмонии
~для бронхиальной астмы
=для бронхопневмонии
}

Амфорическое дыхание наблюдается {
~при очаговой пневмонии
~при бронхите
~при бронхиальной астме
=при абсцессе легкого с прорывом в бронх
~при эмфиземе легких
}

Для какого заболевания характерно появление бронхо-везикулярного дыхания над легкими {
~полость, соединяющаяся с бронхом (диаметром <5 см)
~начальная стадия воспаления доли легкого
~компрессионный ателектаз
=крупозная пневмония
~сужение мелких бронхов
}

Каково течение крупозной и бронхопневмонии в настоящее время {
~резко различается
=стало сходным по многим параметрам
~стало различным по клинике
~стало различным по этиологии
~ни одно из перечисленного
}

Диагностике осложнения пневмонии сухим плевритом помогают {
~возникновения постоянных болей
=возникновение болей, связанных с дыханием
~резкое повышение температуры
~появление резкого притупления
~появление высокого лейкоцитоза
}

Как называется шум, формируемый разлипанием альвеол {
~шум трения плевры
=крепитация
~мелкопузырчатые хрипы
~сухие хрипы
~шум плеска Гиппократ
}

Бронхофония определяется с помощью {
~расспроса
~осмотра
~пальпации
~перкуссии
=аускультации
}

Бронхиальное дыхание выслушивается {
~на вдохе
~на выдохе
~на вдохе и одной трети выдоха
=на протяжении всего вдоха и всего выдоха
~на вдохе и первых двух третях выдоха
}

Крепитация выслушивается {
~в начале вдоха
=в конце вдоха
~в начале выдоха
~в конце выдоха
~в обеих фазах дыхания

}

Везикулярное дыхание, фаза вдоха которого состоит из отдельных коротких прерывистых вдохов, называется {

~амфорическим

=саккадированным

~пуэрильным

~стенотическим

~жестким

}

При абсцессе легкого мокрота имеет {

=густую консистенцию из-за наличия гноя

~вязкую консистенцию из-за присутствия слизи

~жидкую консистенцию, поскольку содержит пропотевшую в бронхи плазму крови

~ржавый цвет из-за примеси крови

~твердый, запекшийся вид

}

Оцените результат исследования плеврального содержимого: относительная плотность - 1027, мутная жидкость, зеленовато-желтого цвета, белок - 60 г/л, проба ривальта ++++, микроскопия осадка - нейтрофилы покрывают все поля зрения {

~транссудат

=гнойный экссудат

~геморрагический (раковый) экссудат

~экссудат при туберкулезном плеврите

~экссудат при туберкулезном плеврите

}

Зловонный запах свежевыделенной мокроты не отмечается при {

~гангрена

~распадающийся рак

~абсцесс

~бронхоэктатическая болезнь

=пневмонии

}

Проба ривальта выявляет наличие {
~глюкозы
~билирубина
~липопротеидов
~холестерина
=серозомуцина
}

Какой характер мокроты характерен для абсцесса легкого и
бронхоэктатической болезни {
~слизистая
~слизисто-гнойная
~гнойная, со зловонным запахом
~слизисто-кровянистая
=гнойно-слизистая, густая, трехслойная
}

В мокроте обнаружен плоский эпителий, это позволяет предположить
наличие {
~бронхиальной астмы
~абсцесса легкого
~хронического бронхита
~митрального стеноза
=ни одного из вышеперечисленного
}

Плевральную пункцию делают {
~по верхнему краю ребра, по лопаточной линии
~по нижнему краю ребра, по лопаточной линии
=по верхнему краю ребра, по задней подмышечной линии
~по нижнему краю ребра, по задней подмышечной линии
~ни одно из вышеперечисленного
}

В мокроте обнаружены эозинофилы в большом количестве, это позволяет
предположить наличие {
=бронхиальной астмы
~абсцесса легкого
~хронического бронхита

~митрального стеноза
~ни одного из вышеперечисленного
}

Гнилостный, зловонный запах мокроты появляется {
~при гангрене легкого, при раке легкого, при абсцессе легкого
~при раке легкого, при абсцессе легкого, при крупозной пневмонии
~при абсцессе легкого, при крупозной пневмонии, при бронхоэктазах
=при гангрене легкого, при абсцессе легкого, при бронхоэктазах
~при раке легкого, при абсцессе легкого, при бронхоэктазах
}

Из перечисленных заболеваний слизисто-кровянистая мокрота характерна для {
~острого трахеобронхита
~бронхопневмонии
~хронического бронхита
=туберкулеза легкого
~крупозной пневмонии
}

Обструктивный тип нарушения вентиляции легких обусловлен {
=сужением просвета бронхов
~уменьшением подвижности диафрагмы
~развитием спаек в плевральной щели
~ослаблением силы дыхательных мышц
~нарушением перфузии
}

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это {
~максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 мин
~объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха
=максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха
~максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха
~ни одного из перечисленных
}

Дыхательный объем (ДО) – это {

~максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха

~максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха

=объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального вдоха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

}

Остаточный объем (ОО) легких - это: {

~максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 мин

=объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

~максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха

~максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха

~максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха

}

Резервный объем (РО) вдоха – это {

=максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха

~максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха

~объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

~ни одно из перечисленного

}

Какие легочные объемы составляют ЖЕЛ {

~ОО, РО вдоха, РО выдоха, ДО, ОЕЛ

=РО вдоха, РО выдоха, ДО

~ОО, РО вдоха, РО выдоха, ОЕЛ

~ОО, РО вдоха, РО выдоха, ОФВ1

~ОО, РО выдоха

}

Выберите характеристику транссудата {

=относительная плотность ниже 1,015, содержание белка меньше 3%

~относительная плотность выше 1,015, содержание белка меньше 3%

~относительная плотность выше 1,025, содержание белка больше 3%

~ни одно из перечисленного

}

Насыщение крови кислородом в норме составляет {

~22-36%

~68-69%

~72-85%

=96-98%

~100%

}

За 1 секунду форсированного выдоха (проба тифно-вотчала) здоровый человек выдыхает {

~20% ЖЕЛ

~40% ЖЕЛ

~60% ЖЕЛ

=80% ЖЕЛ

~сделает весь выдох

}

Минутный объем дыхания в среднем составляет {

~500 мл

~1500-2000 мл

=5000 мл

~10000 мл

~8000 мл

}

Одышка с затруднением фазы выдоха называется {

~физиологической

~субъективной

~инспираторной

=экспираторной

~ни одно из вышеперечисленного

}

Одышка с затруднением фазы вдоха называется

~физиологической

~субъективной

=инспираторной

~экспираторной

~ни одно из вышеперечисленного

}

Жизненная емкость легких зависит {

~от длины тела

~от площади поверхности тела

~от массы тела

~от пола

=от всего перечисленного

}

Резервный объем выдоха – это {

~максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха

=максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха

~объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

}

Максимальная вентиляция легких – это {

~максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха

~максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха

~объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха

~объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха

=максимальный объем воздуха, при максимально возможном глубоком дыхании в течение минуты

}

Бронхиальная обструкция выявляется с помощью {

=спирографии, пикфлуометрии
~бронхоскопии
~исследования газов крови
~аускультации
~перкуссии
}

Простейшим прибором для определения бронхиальной обструкции является
{
~спирограф
=пикфлуометр
~плетизмограф
~флуорограф
~КТ
}

Количественная степень обструкции воздухоносных путей выявляется при
оценке {
~интенсивности кашля и количества выделяемой мокроты
~интенсивности дыхательных шумов над легкими и сухих хрипов
=данных спирографии
~интенсивности дыхательных шумов над легкими и сухих хрипов и с
данными спирографии
~со всем перечисленным
}

Уменьшение жизненной емкости легких выявляется при всех перечисленных
состояниях, кроме {
~воспалительных процессов в органах грудной полости
~беременности (вторая половина)
=грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
~асцита
~эмфиземы легких
}

Наиболее эффективным методом выявления небольшого количества
жидкости в плевральной полости является {
~рентгеноскопия (в обычном положении - ортопозиции)
=рентгенография

~томография
~ЯМР
~УЗИ легких
}

При помощи рентгенографии можно определить

~максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 мин
~объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха
~максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха
~максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть
=ни одного из перечисленных
}

Назовите наиболее вероятную причину боли в случае если резкая боль в правой половине грудной клетки, усиливающаяся при глубоком вдохе и одновременной фиксации грудной клетки руками. боль сопровождается сухим кашлем на высоте вдоха. при наклонах туловища с одновременной задержкой дыхания боль уменьшается {

~воспаление трахеи (трахеит)
=воспаление плевры (сухой плеврит)
~поражение межреберных мышц и нервов
~перенапряжение дыхательных мышц (диафрагмы) при кашле, (мышечные боли).
~крупозная пневмония
}

Назовите наиболее вероятную причину боли в случае если имеется:боль в левой половине грудной клетки, усиливается при наклонах туловища и одновременной задержке дыхания. при фиксации грудной клетки руками и одновременном вдохе боль не усиливается {

~воспаление трахеи (трахеит)
~воспаление плевры (сухой плеврит)
=поражение межреберных мышц и нервов
~перенапряжение дыхательных мышц (диафрагмы) при кашле, (мышечные боли).
~опоясывающий лишай
}

Назовите наиболее вероятную причину боли в случае если имеется чувство саднения (боль) за грудиной, кашель. боль усиливается при кашле, не изменяется при дыхании {

=воспаление трахеи (трахеит)

~воспаление плевры (сухой плеврит)

~поражение межреберных мышц и нервов

~перенапряжение дыхательных мышц (диафрагмы) при кашле, (мышечные боли).

~перенапряжение дыхательных мышц (диафрагмы) при кашле, (мышечные боли).

}

Назовите наиболее вероятную причину кашля: при глубоком вдохе возникает сухой кашель и резкая боль в грудной клетке

~ларингит.

~трахеит, бронхит.

~абсцесс легкого.

~бронхиальная астма

=сухой плеврит

}

Назовите наиболее вероятную причину кашля: кашель со скудной мокротой слизистого и слизисто-гнойного характера {

~ларингит.

=трахеит, бронхит.

~абсцесс легкого.

~бронхиальная астма

~сухой плеврит

}

Назовите наиболее вероятную причину кашля: кашель с отделением жидкой зеленоватой мокроты с зловонным запахом. мокрота отхаркивается "полным ртом" {

~ларингит.

~трахеит, бронхит.

=абсцесс легкого.

~бронхиальная астма

~сухой плеврит

}

Назовите наиболее вероятную причину кашля: кашель с трудно отделяемой стекловидной вязкой "белой" мокротой в небольшом количестве.

сопровождается экспираторной одышкой {

~ларингит.

~трахеит, бронхит.

~абсцесс легкого.

=бронхиальная астма

~сухой плеврит

}

Дайте название одышки: больной жадно "хватает" воздух, имеется ощущение неполноты вдоха {

~тахипное

=инспираторная одышка

~стридорозное дыхание

~экспираторная одышка

~дыхание Чейн-Стокса

}

Дайте название одышки: ощущение нехватки воздуха, удлиненный выдох с участием мышц плечевого пояса {

~тахипное

~инспираторная одышка

~стридорозное дыхание

=экспираторная одышка

~дыхание Чейн-Стокса

}

Дайте название одышки: резко затруднен вдох и выдох, шейные мышцы напряжены, на вдохе и выдохе дыхание шумное, слышимое на расстоянии.

{

~тахипное

~инспираторная одышка

=стридорозное дыхание

~экспираторная одышка

~дыхание Куссмауля

}

Дайте название одышки: имеется частое поверхностное дыхание, без затруднения вдоха и выдоха {

=тахипное

~инспираторная одышка

~стридорозное дыхание

~экспираторная одышка

~дыхание Куссмауля

}

Дайте название одышки: глубокое редкое шумное дыхание у больного, находящегося в коме {

~экспираторная одышка

~инспираторная одышка

~стридорозное дыхание

~дыхание Чейн-Стокса

=дыхание Куссмауля

}

Перкуторно плевральный экссудат определяется при его объеме не менее {

~50 мл

~100 мл

=200 мл

~500 мл

~500 мл

}

Длительное кровохарканье при сухом кашле заставляет, прежде всего, подозревать {

=рак бронха

~кавернозный туберкулез легких

~бронхоэктатическую болезнь

~пневмокониоз

~сухой плеврит

}

Назовите наиболее частую причину дыхания куссмауля {

~уменьшение чувствительности дыхательного центра, вследствие токсических воздействий на ЦНС

=стадия декомпенсации сахарного диабета, хроническая почечная

недостаточность

~препятствие в верхних дыхательных путях (опухоль гортани, главного бронха, инородное тело)

~спазм мелких бронхов и закупорка их вязкой мокротой

~поражение альвеолярной ткани (уменьшение растяжимости легких, их дыхательной поверхности)

}

Укажите чем характеризуется септический тип лихорадки {

~постоянной температурой 38-39°C

~колебаниями температура в пределах 1 °C

=колебаниями между утренней и вечерней 2 и более °C

~колебаниями температуры от 37 до 38 °C

~ни одной из них

}

Назовите наиболее частую причину диффузного цианоза кожи {

~острый бронхит

~хронический бронхит

=пневмосклероз и легочное сердце

~сердечная недостаточность

~бронхиальная астма

}

Назовите причину периферического цианоза (стоп, голеней, кистей рук) {

~дыхательная недостаточность.

=сердечная недостаточность

~почечная недостаточность.

~печеночная недостаточность.

~недостаточность надпочечников

}

Назовите причину центрального цианоза (лица, верхней части тела) {

=дыхательная недостаточность.

~сердечная недостаточность

~почечная недостаточность.

~печеночная недостаточность.

~ни одна из них

}

При каких бронхолегочных заболеваниях и поражениях наблюдаются ослабление на пораженной стороне голосового дрожания и бронхофонии {
=гидроторакс, экссудативный плеврит
~острая пневмония
~обтурационный ателектаз
~полость в легком, сообщающаяся с бронхом
~эмфизема легких
}

При каких поражениях дыхательной системы наблюдается абсолютно тупой (бедренный) перкуторный звук {
=гидроторакс, экссудативный плеврит
~закрытый пневмоторакс
~пневмофиброз
~острая пневмония
~обтурационный ателектаз
}

При каких заболеваниях и поражениях легких наблюдается тимпанический перкуторный звук
~компрессионный ателектаз
=закрытый пневмоторакс
~эмфизема легких
~острая пневмония
~полость в легком, сообщающаяся с бронхом
}

Ниже перечислены основные медиаторы выходящие в кровь при специфической активации тучных клеток, исключите один лишний {
~гистамин
=норадреналин
~серотонин
~гепарин
~ацетилхолин
}

При каких заболеваниях и поражениях бронхолегочной системы наблюдается коробочный перкуторный звук {

~компрессионный ателектаз
~закрытый пневмоторакс
=эмфизема легких
~острая пневмония
~полость в легком, сообщающаяся с бронхом
}

При каких заболеваниях и поражениях бронхолегочной системы наблюдается амфорическое дыхание {

~компрессионный ателектаз
~закрытый пневмоторакс
~эмфизема легких
~острая пневмония
=полость в легком, сообщающаяся с бронхом
}

Чем обусловлено появление крепитации {

~спазм мелких бронхов и вязкая мокрота в них
~воспаление листков плевры (сухой плеврит)
~жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей легочной ткани
~жидкая мокрота в мелких бронхах с воспалительным уплотнением окружающей легочной ткани
=наличие в альвеолах небольшого количества фибринозного экссудата или транссудата (пристеночно)
}

Чем обусловлено появление сухих свистящих хрипов {

=спазм мелких бронхов и вязкая мокрота в них
~вязкая мокрота в крупных бронхах
~жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей легочной ткани
~жидкая мокрота в мелких бронхах с воспалительным уплотнением окружающей легочной ткани
~наличие в альвеолах небольшого количества фибринозного экссудата или транссудата (пристеночно)
}

Чем обусловлено появление сухих жужжащих (басовых) хрипов {

~спазм мелких бронхов и вязкая мокрота в них
=вязкая мокрота в крупных бронхах
~жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности
окружающей легочной ткани
~жидкая мокрота в мелких бронхах с воспалительным уплотнением
окружающей легочной ткани
~наличие в альвеолах небольшого количества фибринозного экссудата или
транссудата (пристеночно)
}

Чем обусловлено появление шума трения плевры {
~спазм мелких бронхов и вязкая мокрота в них
~вязкая мокрота в крупных бронхах
~жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности
окружающей легочной ткани
~жидкая мокрота в мелких бронхах с воспалительным уплотнением
окружающей легочной ткани
=ни одно из вышеперечисленного
}

Какое заболевание имеется у больного справа ниже угла лопатки
определяется усиление голосового дрожания и бронхофонии, притупление
перкуторного звука, бронхиальное дыхание и шум трения плевры {
~компрессионный ателектаз
=крупозная плевропневмония в стадии разгара
~очаговая пневмония
~экссудативный плеврит
~экссудативный плеврит
}

Какое заболевание имеется у больного в правой подлопаточной области
определяется усиление голосового дрожания и бронхофонии, умеренное
притупление перкуторного звука, бронховезикулярное дыхание и влажные
мелкопузырчатые звонкие хрипы {
~гидроторакс
~компрессионный ателектаз Крупозная пневмония
=очаговая пневмония (бронхопневмония)
~полость в легком, сообщается с бронхом
~полость в легком, сообщается с бронхом

}

Какое заболевание имеется у больного слева от середины лопатки и ниже, а также в левой подмышечной области - тупой (бедренный) перкуторный звук, нижние межреберья сглажены, голосовое дрожание не проводится, дыхание на уровне угла лопатки резко ослаблено, а ниже - не слышно {

=гидроторакс (экссудативный плеврит)

~долевое воспалительное уплотнение

~полость в легком, сообщается с бронхом

~компрессионный ателектаз

~эмфизема легких

}

Какое заболевание имеется у больного: высокая температура, сухой кашель, боли в правой половине грудной клетки, ограничение подвижности легких там же {

~гидроторакс

~долевое воспалительное уплотнение

~полость в легком, сообщается с бронхом

~компрессионный ателектаз

=ни одно из перечисленных

}

Можно ли по характеру мокроты провести дифференциацию крупозной пневмонии, очаговой пневмонии, абсцесса легкого и бронхоэктатической болезни. {

~нет, нельзя

~не всегда

=можно

~не знаю

~едва ли

}

При острой пневмонии поражается все перечисленное, кроме {

=крупных бронхов

~дыхательных бронхиол

~альвеол

~интерстиция легких

~плевры

}

Диагноз пневмонии устанавливается на основании {

~клинических симптомов заболевания

~данных физикального исследования

~результатов рентгенологического исследования легких

~показателей лабораторных анализов

=всего перечисленного

}

Возбудителем пневмонии чаще всего является {

=пневмококк

~стрептококк

~стафилококк

~кишечная палочка

~клебсиелла

}

Примерно на какой день от начала крупозной пневмонии выявляется

crepitatio indux {

=на первый-второй

~на третий- пятый

~на шестой-седьмой

~на восьмой-десятый

~на двенадцатый - тринадцатый

}

Примерно на какой день от начала крупозной пневмонии выявляется

crepitatio redux {

~на первый-второй

~на третий- пятый

=на шестой-седьмой

~на восьмой-десятый

~на двенадцатый - тринадцатый

}

Что выявляется в легком рентгенологически при крупозной пневмонии {

=затемнение доли легкого

~усиление легочного рисунка

~просветление ткани легкого
~инфильтраты
~полость
}

Какие общие моменты играют большую роль в развитии острых пневмоний {
~переохлаждение
=все перечисленное
~курение
~травмы грудной клетки
~застой в легких
}

Какой тип аллергической реакции имеет наибольшее значение в развитии приступов бронхиальной астмы {
=первый
~второй
~третий
~четвертый
~первый и второй
}

"Барабанные палочки" это {
~распространенные массивные отеки пальцев кисти
~окрашивание кожи пальцев кисти в желтый с зеленоватым оттенком цвет
=утолщение концевых фаланг пальцев кисти
~покраснение кожи в области тенара и гипотенара
~ни одно из вышеперечисленного
}

Какие жалобы не характерны для больных с заболеванием лёгких {
~кашель
~боль в грудной клетке, связанная с актом дыхания
~одышка, приступы удушья
~кровохарканье
=частое болезненное мочеиспускание
}

Какое утверждение в отношении шума трения плевры неверно {

~образуется при трении изменённых плевральных листков друг о друга

~выслушивается одинаково на вдохе и выдохе

~не меняется при кашле

~определяется при пальпации грудной клетки

=выслушивается только на выдохе

}

Что не служит признаками наличия выпота в плевральной полости {

~одышка

~резкое притупление перкуторного звука

=влажные звучные хрипы

~ослабление голосового дрожания

~отсутствие дыхательных шумов

}

Над полостью вскрывшегося абсцесса аускультативно определяется {

~ослабленное везикулярное дыхание

=амфорическое дыхание

~жесткое дыхание

~стенотическое дыхание

~отсутствие дыхательных шумов

}

Для эмфиземы легких характерен следующий тип дыхания {

~бронхиальное

~амфорическое

=ослабленное везикулярное

~саккадированное

~стенотическое

}

Для больного с эмфиземой характерен следующий тип грудной клетки {

~паралитический

~рахитический

=бочкообразный

~ладьевидный

~астенический

}

Вовлечение в процесс плевры характеризует появление симптома {

- ~усиления везикулярного дыхания
 - =боли в грудной клетке при дыхании
 - ~кровохарканья
 - ~"ржавой" мокроты
 - ~инспираторной одышки
- }

Для острого бронхита характерно {

- ~ослабление бронхофонии
 - ~влажные звонкие хрипы
 - =жесткое дыхание
 - ~бочкообразная грудная клетка
 - ~крепитация
- }

Для больных с бронхоэктатической болезнью характерен кашель {

- ~лающий
 - ~усиливающийся вечером
 - ~ночной
 - =утренний с выделением большого количества мокроты
 - ~с выделением "ржавой" мокротой
- }

У больного с бочкообразной грудной клеткой определяется следующий перкуторный звук {

- ~тимпанический
 - ~притупленный
 - ~притупленно-тимпанический
 - =коробочный
 - ~металлический
- }

При выслушивании легких больного выявлены отрывистые звуки, появляющиеся на высоте вдоха и напоминающие треск волос при растирании вблизи уха. выявлено наличие {

- ~сухих хрипов

~влажных незвонких хрипов
~влажных звонких хрипов
~шума трения плевры
=крепитации
}

Для острого бронхита характерен следующий основной дыхательный шум {
=жесткое дыхание
~бронхиальное дыхание
~везикулярное дыхание
~амфорическое дыхание
~стенотическое дыхание
}

Транссудат в плевральной полости появляется при {
~туберкулезе
=сердечной недостаточности
~ревматизме
~раке легкого
~крупозной пневмонии
}

Для стадии уплотнения крупозной пневмонии характерен следующий перкуторный звук {
~тимпанический
~ясный легочный
~коробочный
=тупой
~притупленно-тимпанический
}

Окологрудинная линия проходит {
~по краям грудины
=на середине расстояния между срединно-ключичной и грудинной линиями
~по середине грудины
~через средину ключицы

~ по грудинной линии

}

Горизонтальная линия, проведенная через углы лопаток, соответствует проекции ... на грудную клетку. {

=VII ребер

~VI ребер

~V ребер

~VIII ребер

~ IV ребер

}

Ригидность грудной клетки бывает выраженной при{

~бронхиальной астме

~эмфиземе легких

=экссудативном плеврите

~бронхите

}

Какие свойства соответствуют ясному легочному перкуторному звуку? {

=громкий и продолжительный.

~тихий и короткий.

~низкий.

~высокий.

}

Притупленный перкуторный звук при синдроме уплотнения легочной ткани может выявляться в случаях {

=неполного уплотнения

~полного отсутствия воздуха в очаге поражения

~очага поражения в пределах доли

~очага поражения в пределах доли и полного отсутствия воздуха в нем

}

При синдроме уплотнения легочной ткани перкуторный звук может не изменяться в случае {

~неполного уплотнения

~полного отсутствия воздуха в очаге поражения

~очага поражения в пределах доли

~очага поражения в пределах доли

=очага поражения в прикорневой зоне

}

136

Блок В (25%)

ТЗ Форма 2²

Везикулярное дыхание ослабевает {

~%-33.33333% при бронхопневмонии

~%50% при крупозной пневмонии

~%-33.33333% при бронхоэктатической болезни

~%-33.33333% при сухом плеврите

~%50% при экссудативном плеврите

}

Каковы изменения показателей функции внешнего дыхания при приступе бронхиальной астмы {

~%-33.33333% ЖЕЛ увеличена

~%50% ФЖЕЛ уменьшена

~%-33.33333% МВЛ увеличена

~%50% Пикфлоуметрия - пиковая скорость выдоха снижена

~%-33.33333% МОД снижен

}

Назовите наиболее частые причины плеврита {

~%33.33333% туберкулез
~%33.33333% ревматизм
~%-50% стрептококковая инфекция
~%33.33333% рак легких
~%-50% пситаккоз
}

Выберете признаки, наиболее характерные для центрального цианоза {
~%-50% акроцианоз.
~%50% диффузный цианоз.
~%50% "теплый" цианоз.
~%-50% "холодный" цианоз
}

Выберете признаки, наиболее характерные для периферического цианоза {
~%50% акроцианоз.
~%-33.33333% диффузный цианоз.
~%-33.33333% "теплый" цианоз.
~%50% "холодный" цианоз
~%-33.33333% периодический цианоз
}

Назовите наиболее вероятные причины появления симптома "барабанных палочек" и "часовых стекол" {
~%-33.33333% хронический бронхит
~%50% бронхоэктатическая болезнь
~%-33.33333% эмфизема легких
~%-33.33333% острая пневмония
~%50% хронический абсцесс легких
}

При каких бронхолегочных заболеваниях и поражениях наблюдается притупление (укорочение) перкуторного звука {
~%-33.33333% гидроторакс
~%-33.33333% закрытый пневмоторакс
~%-33.33333% пневмофиброз
~%50% острая пневмония
~%50% обтурационный ателектаз
}

При каких заболеваниях и поражениях бронхолегочной системы наблюдается патологическое бронхиальное дыхание {

~%33.33333% ателектаз

~%-50% закрытый пневмоторакс

~%-50% эмфизема легких

~%33.33333% острая пневмония

~%33.33333% полость в легком, сообщающаяся с бронхом

}

При каких заболеваниях и поражениях бронхолегочной системы наблюдается ослабленное дыхание на стороне поражения {

~%33.33333% гидроторакс (экссудативный плеврит)

~%33.33333% закрытый пневмоторакс

~%-50% пневмофиброз

~%-50% острая пневмония

~%33.33333% ателектаз

}

При каких заболеваниях и поражениях бронхолегочной системы наблюдается ослабление везикулярного дыхания с обеих сторон {

~%-33.33333% гидроторакс (экссудативный плеврит)

~%-33.33333% закрытый пневмоторакс.

~%50% пневмофиброз

~%-33.33333% острая пневмония

~%50% эмфизема легких

}

Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме обусловлена {

~%33.33333% бронхоспазм

~%33.33333% воспалительным отеком слизистой оболочки бронхов

~%33.33333% закрытием просвета бронхов вязким секретом

~%-50% спадением мелких бронхов на выдохе

~%-50% всем перечисленным

}

Выберите жалобы и проявления первых дней при крупозной пневмонии {

~%-50% рвота

~%33.33333% головная боль

~%50% выделение слизисто гнойной мокроты
~%33.33333% озноб
~%33.33333% сухой кашель
}

Выберите признаки крупозной пневмонии 3-4 дня {
~%33.33333% ржавая мокрота
~%33.33333% herpes nosalis et labialis
~%50% везикулярное дыхание
~%50% ясный легочный звук
~%33.33333% шум трения плевры
}

Признаки патоморфоза крупозной пневмонии {
~%50% отсутствие озноба
~%33.33333% частое осложнение абсцессом или эмпиемой плевры
~%50% кратковременность лихорадочного периода
~%33.33333% более высокий, чем ранее лейкоцитоз яркая картина
долевого поражения легких
~%33.33333% более высокий, чем ранее лейкоцитоз яркая картина
долевого поражения легких
}

Какую часть легкого может захватывать воспалительный процесс при классическом течении крупозной пневмонии {
~%50% несколько долек
~%33.33333% несколько долей
~%50% несколько сегментов
~%33.33333% долю легкого
~%33.33333% легкое целиком
}

Какая мокрота наблюдается при крупозной пневмонии {
~%33.33333% скудная
~%33.33333% очень вязкая
~%50% очень жидкая
~%50% гнойная
~%33.33333% фибринозная
}

Какие аускультативные явления могут наблюдаться при крупозной пневмонии {

- ~%33.33333% сухие хрипы, жесткое дыхание
 - ~%50% усиление бронхофонии, крепитация
 - ~%33.33333% ослабление бронхофонии, влажные хрипы
 - ~%50% ослабление дыхания, шум трения плевры
 - ~%33.33333% везикулярное дыхание
- }

Какие вы знаете названия крупозной пневмонии (синонимы) {

- ~%33.33333% фибринозная
 - ~%33.33333% лобарная
 - ~%50% бронхопневмония
 - ~%50% сегментарная
 - ~%33.33333% долевая
- }

Какие вы знаете названия бронхопневмонии (синонимы) {

- ~%33.33333% фибринозная
 - ~%33.33333% лобарная
 - ~%50% очаговая
 - ~%50% сегментарная
 - ~%33.33333% долевая
- }

Выберите основные этиологические факторы атопической формы бронхиальной астмы {

- ~%33.33333% генетические дефекты
 - ~%33.33333% бытовые аллергены, лекарства Измененная реактивность бронхов
 - ~%33.33333% иммунные процессы сенсибилизации
 - ~%50% психические факторы
 - ~%50% контакт с больными астмой
- }

Назовите наиболее вероятные причины следующих изменений в грудной клетке: правая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания, там же отмечается ослабление бронхофонии и голосового дрожания {

~%50% гидроторакс
~%33.33333% пневмоторакс
~%33.33333% пневмофиброз
~%33.33333% острая пневмония
~%50% экссудативный плеврит
}

Что позволяет выявить осмотр больного с патологией лёгких {
~%33.33333% герпес
~%33.33333% пальцы в виде "барабанных палочек", ногти в виде "часовых стёкол"
~%33.33333% "тёплый" цианоз
~%50% узловатую эритему
~%50% экзофтальм
}

Что позволяет определить пальпация грудной клетки {
~%50% бронхофонию
~%33.33333% резистентность грудной клетки
~%33.33333% болезненные места, треск, напоминающий крепитацию
~%33.33333% голосовое дрожание
~%50% влажные звонкие хрипы
}

При каких состояниях возникает ослабление голосового дрожания {
~%50% при сухом плеврите
~%33.33333% экссудативный плеврит
~%33.33333% гидроторакс
~%33.33333% у тяжёлых, ослабленных больных
~%50% хронический бронхит
}

Тупой звук возникает при наличии в лёгких {
~%50% полости
~%33.33333% выпота
~%33.33333% выраженных утолщений плевры
~%33.33333% инфильтрации лёгочной ткани
~%50% увеличения содержания воздуха в лёгких
}

При каких заболеваниях лёгких возможно появление кровохарканья {

~%33.33333% пневмония

~%33.33333% бронхоэктатическая болезнь

~%33.33333% инфаркт легкого

~%-50% бронхиальная астма

~%-50% экссудативный плеврит

}

К основным дыхательным шумам при аускультации лёгких у здорового человека относят {

~%-33.33333% шум трения плевры

~%-33.33333% амфорическое дыхание

~%50% везикулярное дыхание

~%50% бронхиальное дыхание над трахеей, гортанью, крупными бронхами

~%-33.33333% крепитация

}

Какие аускультативные феномены выступают в качестве свидетельством патологического процесса в лёгких {

~%33.33333% жёсткое дыхание

~%-50% пуэрильное дыхание

~%33.33333% бронхиальное дыхание над долей лёгкого

~%-50% везикулярное дыхание

~%33.33333% удлинённый выдох

}

Сухие хрипы образуются {

~%-50% при разлипании стенок альвеол на высоте вдоха

~%33.33333% при набухании слизистой оболочки бронхов и сужении их просвета

~%33.33333% при спазме мелких бронхов

~%-50% при прохождении воздуха через бронхи с жидким секретом

~%33.33333% при прохождении воздуха через бронхи с вязкой мокротой

}

Звонкие влажные хрипы {

~%50% возникают в бронхах при наличии в них жидкого экссудата

~%-33.33333% выслушиваются при воспалении слизистой оболочки бронхов
~%-33.33333% выслушиваются при застойных явлениях в малом круге кровообращения
~%50% выслушиваются при очаговой пневмонии
~%-33.33333% изменяют характер или исчезают при покашливании
}

Что характерно для крепитации {
~%-50% выслушивается в обе фазы дыхательного цикла
~%33.33333% выслушивается только на высоте вдоха
~%33.33333% возникает в альвеолах при наличии в них небольшого количества экссудата
~%33.33333% не изменяется после откашливания
~%-50% усиливается при надавливании стетоскопом на грудную клетку
}

Назовите патологические формы грудной клетки. {
~%33.33333% эмфизематозная.
~%-50% гиперстеническая.
~%33.33333% воронкообразная.
~%-50% астеническая.
~%33.33333% паралитическая.
}

Назовите нормальные формы грудной клетки. {
~%-50% эмфизематозная.
~%33.33333% гипертоническая.
~%33.33333% нормостеническая.
~%33.33333% астеническая.
~%-50% атоническая.
}

Что соответствует астенической форме грудной клетки? {
~%33.33333% эпигастральный угол меньше 90°.

~%50% узкие межреберные промежутки.

~%33.33333% грудной индекс меньше 0,65.

~%33.33333% ребра в боковых отделах приобретают вертикальное направление.

~%50% хорошо выражен угол Людовика.

}

Что соответствует гиперстенической форме грудной клетки? {

~%33.33333%эпигастральный угол больше 90°.

~%50% эпигастральный угол равен 90°.

~%33.33333% грудной индекс больше 0,75.

~%33.33333% направление ребер приближается к горизонтальному.

~%50% эпигастральный угол меньше 90°.

}

Что соответствует гиперстенической форме грудной клетки? {

~%50% эпигастральный угол больше 90°.

~%33.33333% широкие межреберные промежутки.

~%33.33333% грудной индекс 0,65-0,75.

~%33.33333% ребра в боковых отделах приобретают вертикальное направление.

~%50% хорошо выражен угол Людовика.

}

Эмфизематозная грудная клетка {

~%33.33333% напоминает гиперстеническую

~%50% напоминает нормостеническую

~%50% межреберные промежутки узкие

~%33.33333% межреберные промежутки широкие

~%33.33333% возникает у пациентов с эмфиземой легких

}

С помощью динамического осмотра грудной клетки определяют {

~%33.33333% Тип дыхания

~%-50% расположение ключиц

~%33.33333% симметричность участия половин грудной клетки в акте дыхания

~%-50% состояние диафрагмы

~%33.33333% состояние межреберных промежутков

}

Уменьшение объема одной из половин грудной клетки может быть обусловлено {

~%50% обтурацией центрального бронха

~%-50% пневмотораксом

~%50% хирургическим удалением доли или всего легкого

~%-50% гидротораксом

}

При пальпации грудной клетки можно определить

~%-50% расположение границ легких

~%-50% подвижность нижних краев легких

~%33.33333% локализацию и причину боли

~%33.33333% резистентность грудной клетки

~%33.33333% голосовое дрожание

}

Голосовое дрожание усилено при синдроме {

~%50% уплотнения легочной ткани

~%-33.33333% повышения воздушности легочной ткани

~%-33.33333% скопления жидкости в полости плевры

~%50% образования в легком полости, сообщающейся с бронхом

~%-33.33333% скопления воздуха в полости плевры

}

Голосовое дрожание ослаблено при синдроме {

~%-50% уплотнения легочной ткани

~%33.33333% повышения воздушности легочной ткани

~%33.33333% скопления жидкости в полости плевры

~%33.33333% скопления воздуха в полости плевры

~%-50% воспаления бронхов

}

Для каких заболеваний характерно усиление голосового дрожания? {

~%-33.33333% для бронхиальной астмы.

~%50% для долевой пневмонии.

~%-33.33333% для эмфиземы легких.

~%50% для абсцесса легких после вскрытия.

~%-33.33333% для острого бронхита.

}

Для каких заболеваний характерно ослабление голосового дрожания? {

~%33.33333% для экссудативного плеврита.

~%33.33333% для пневмоторакса.

~%-50% для очаговой пневмонии.

~%-50% Для абсцесса легких после вскрытия.

~%33.33333% для бронхиальной астмы (во время приступа).

}

Голосовое дрожание ослаблено при {

~%33.33333% эмфиземе легких

~%-50% пневмосклерозе

~%33.33333% центральном раке легких (при полной обтурации бронха)

~%33.33333% экссудативном плеврите

~%-50% бронхоэктатической болезни

}

Перкуссия грудной клетки помогает в диагностике заболеваний

~%-50% верхних дыхательных путей

~%50% легких

~%50% плевры

~%-50% всех перечисленных органов

}

Метод перкуссии легких помогает определить. {

~%-50% эластичность грудной клетки

~%33.33333% характер патологического синдрома

~%33.33333% границы легких

~%33.33333% максимальную дыхательную экскурсию нижнего легочного края

~%-50% максимальную дыхательную экскурсию грудной клетки

}

Коробочный перкуторный звук может выявляться при . {

~%-33.33333% очаговой пневмонии

~%50% бронхиальной астме

~%-33.33333% абсцессе легкого после вскрытия

~%50% эмфиземе легких

~%-33.33333% крупозной пневмонии в стадии разрешения

}

Тупой звук при синдроме уплотнения легочной ткани может выявляться в случаях. {

~%-33.33333% неполного уплотнения

~%50% полного отсутствия воздуха в очаге поражения

~%-33.33333% очага поражения в пределах доли

~%50% очага поражения в пределах доли

~%-33.33333% очага поражения в прикорневой зоне

}

При каких заболеваниях может выявляться тупой перкуторный звук? {

~%-33.33333% при эмфиземе легких.

~%-33.33333% при бронхитах.

~%-33.33333% при сухом плеврите.

~%50% при экссудативном плеврите.

~%50% при крупозной пневмонии во 2 стадию заболевания.

}

Притупленный перкуторный звук может выявляться при {

~%-33.33333% эмфиземе легких

~%50% экссудативном плеврите

~%50% пневмонии

~%-33.33333% хроническом бронхите

~%-33.33333% бронхиальной астме

}

При каких заболеваниях выявляется тимпанический звук? {

~%-33.33333% при эмфиземе легких.

~%-33.33333% при бронхиальной астме.

~%50% при пневмотораксе.

~%50% при абсцессе легких во 2 стадию.

~%-33.33333% при остром бронхите.

}

Какие изменения в крови и в мокроте могут подтвердить диагноз бронхиальной астмы {

~%50% в крови эозинофилия

~%50% в мокроте - много эозинофилов

~%-33.33333% в мокроте - мало эозинофилов

~%-33.33333% в мокроте - нет кристаллов Шарко-Лейдена

~%-33.33333% в мокроте - нет спиралей Куршмана

}

Экспираторная одышка наиболее часто наблюдается {

~%-33.33333% при сердечной астме

~%-33.33333% при банальном бронхите

~%50% при обструктивном бронхите

~%-33.33333% при хронической сердечной недостаточности

~%50% при бронхиальной астме

}

При очаговой пневмонии {

~%50% мокрота серозно гнойная

~%-33.33333% мокрота вязкая, коричневатая

~%-33.33333% мокроты много

~%50% возбудитель проникает из бронхов

~%-33.33333% возбудитель попадает в легкие через кровь

}